

# Gestão de Planos de Saúde

MILENA BARBOSA DE MELO  
CRISTINA SPENGLER LAMBUJA



Unidade 1

Livro Didático  
Digital





Diretor Executivo  
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial  
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico  
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autoras  
MILENA BARBOSA DE MELO  
CRISTINA SPENGLER LAMBUJA

Desenvolvedor  
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

# AS AUTORAS

## Milena Barbosa de Melo e Cristina Spengler Lambuja

Eu, Milena, possuo graduação em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (2004). Doutora em Direito Internacional pela Universidade de Coimbra. Mestre e Especialista em Direito Comunitário pela Universidade de Coimbra. Atualmente sou Professora Universitária e Conteudista. Como jurista atuo principalmente nas seguintes áreas: Direito à Saúde, Direito Internacional público e privado, Jurisdição Internacional, Direito Empresarial, Direito do Desenvolvimento, Direito da Propriedade Intelectual e Direito Digital

Eu, Cristina, sou Consultora Organizacional e Coaching Executiva. Graduada em História e Mestre em Ciências Humanas pela UNISINOS (SL-2006), especialista em Pedagogia Empresarial pela FEEVALE (NH-2010), especialista em Psicologia Organizacional (ESADE-PA), especialista em Educação à Distância, com ênfase e docência e tutoria em EAD ( PUC-RS), Member Coach pela Associação Latino Americana de Coaching (SLAC-SP-2013), credenciada PMI (projetos), certificada Analista Comportamental DISC, professora convidada no MBA de Gestão de Pessoas da FAPA, FEEVALE e UNISINOS, consultora organizacional especializada em educação corporativa, desenvolvimento de equipes, inovação e liderança. Bolsista PIBIC (2000/2002), CNPQ (2011), Projeto: Inserção de mestres e doutores na indústria para promoção da Inovação. Professora orientadora e tutora do CERFEaD, Instituto Federal de Santa Catarina no curso de pós-graduação em Gestão pública, consultora externa da FIERGS nos programas de Inovação e Consultoria para Educação de Qualidade, atuando na formação em gestão de equipes diretivas de escolas no estado do Rio Grande do Sul e no programa Educação para o mundo do trabalho. Voluntária em projetos de orientação profissional e preparação para o trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade social. Experiência de mais de 15 anos coordenando projetos em empresas de diversos segmentos na área de EDUCAÇÃO CORPORATIVA (EPCOS/TDK, PIRELLI, COSMOBEL BEAUTY STORE, BALAS FLORESTAL, CAMERA GRÃOS, WDS PNEUMÁTICOS, SACOPLAST, TRAMONTINA, TINTAS KILLING, FATI FERRAMENTAS, LABORATÓRIO DO PÉ – BRASIL, etc.), instituições (FIERGS/SESI/SEBRAE/SEDAE) e prefeituras (CAXIAS DO SUL, ESTÂNCIA VELHA, PAULO BENTO, PINHEIRO MACHADO, SÃO LEOPOLDO, ETC.).

Desse modo, fomos convidadas pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estamos muito felizes em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte conosco!

# ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



**INTRODUÇÃO:**  
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



**NOTA:**  
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



**EXPLICANDO MELHOR:**  
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



**SAIBA MAIS:**  
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



**ACESSE:**  
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



**ATIVIDADES:**  
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



**DEFINIÇÃO:**  
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



**IMPORTANTE:**  
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



**VOCÊ SABIA?**  
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



**REFLITA:**  
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



**RESUMINDO:**  
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



**TESTANDO:**  
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

# SUMÁRIO

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Saúde Suplementar.....</b>                                               | <b>11</b> |
| Problema com o SUS.....                                                     | 15        |
| <b>A lei nº9961/2000 – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).....</b> | <b>17</b> |
| Estrutura básica da ANS.....                                                | 29        |
| <b>Gestão Financeira e Orçamentária da Saúde Suplementar.....</b>           | <b>51</b> |
| Conceito de Gestão Financeira e Orçamentária .....                          | 51        |
| <b>Infraestrutura Básica da ANS.....</b>                                    | <b>55</b> |



# UNIDADE

# 01

LIVRO DIDÁTICO DIGITAL

# INTRODUÇÃO

A Saúde Suplementar é um assunto antigo no meio social. Com o descaso do SUS, pessoas preferiram procurar assistência privada para que suas consultas pudessem ser realizadas mais rápido e com mais comodidade. Mas nem sempre a saúde suplementar foi como é no tempo atual, ela passou por uma transformação para que pudesse ser algo que garantisse o efetivo direito dos seus beneficiários.

Em meio a transformação surgiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada para controlar os planos de saúde e garantir todos os direitos dos beneficiários.

A ANS foi criada como uma agência reguladora, possuindo uma estrutura toda tipificada em uma Resolução. Como órgão bem formado e independente, possui sua gestão financeira, tipifica normas para seu serviço e suas decisões possuem caráter definitivo.

Diante do exposto, essa Unidade está organizada para que você adquira o conhecimento necessário sobre a saúde suplementar, seus desdobramentos e sobre a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Preparados? Vamos lá!

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- 1.** Compreender como surgiu a saúde suplementar e seus desdobramentos;
- 2.** Analisar a Agência Nacional de Saúde e suas perspectivas;
- 3.** Identificar a estrutura básica da ANS e suas peculiaridades;
- 4.** Entender sobre orçamento, receita e despesa geral da ANS e sua aplicabilidade;

E então? Preparado para discorrermos sobre estes fascinantes assuntos que lhe trarão conhecimentos importantíssimos? Bora lá conosco!

# Saúde Suplementar



## OBJETIVO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona a saúde suplementar no Brasil e suas peculiaridades e, além disso, aprenderá a respeito do SUS (Sistema Único de Saúde), seus requisitos de funcionamento e sua gestão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Antes de começar os estudos sobre a regulamentação da saúde suplementar, sua gestão financeira e orçamentária e todas as questões que serão abordadas nesse material, devemos primeiro explicar o que vem a ser a saúde suplementar, para que ao término do capítulo possamos entender melhor todo o contexto da saúde suplementar.

A saúde suplementar surgiu no Brasil em meados dos anos 1960, em São Paulo com a empresa de Medicina em Grupo, com o nome de Policlínica Central. Em 1960, devido ao crescimento das empresas e seu aumento no número de funcionários, graças ao avanço do mercado, as empresas começaram a fornecer planos de assistência médica, firmando parceria com o Estado, e, assim, celebrando convênios com o Instituto de Aposentadoria e Pensões. As empresas descontavam do valor devido ao Instituto Nacional de Previdência Social 2% na folha de pagamento de cada funcionário. Assim, a saúde suplementar se tornou a prática de operação de planos ou seguros de saúde.

Com a crise econômica da década de 80 que diminuiu os recursos governamentais, houve uma queda na qualidade da assistência à saúde do setor público, então as pessoas passaram a valorizar mais o sistema privado. Ao notar isso, as empresas de Medicina de Grupo começaram a investir no setor privado.



Fonte: @freepik

A Constituição Federal de 1988 em seu art.196 traz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e em seu art.199 garantiu o direito à assistência privada à saúde, funcionando de maneira complementar ao Sistema Único de Saúde, devendo ser mediante contrato público ou convênio.

Até 1998, essa atividade não era regulamentada, o que ocasionava muitas reclamações dos beneficiários dos planos de saúde no Programa Estadual de Defesa do Consumidor (Procon) que já havia sido criado com o advento do Código de Defesa do Consumidor em 1990, essas reclamações se baseavam em queixas com respeito ao aumento excessivo das mensalidades, cláusulas abusivas, entre outras.

Desde 1990 devido as inúmeras reclamações, começou a ser pautada a regulação da saúde suplementar. Então, em 1998, foi sancionada a Lei nº 9656, que regulamentou os planos de saúde, elencando as regras dos planos assistenciais privados e efetivando as garantias para todos

aqueles que já participavam e que iriam ingressar na saúde suplementar.

Com o advento dessa Lei, no ano 2000, como complementação da Lei nº9656, foi sancionada a Lei nº9961 que trouxe a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Se torna importante ressaltar que quem adere aos planos de saúde suplementar não perde o direito ao Sistema único de Saúde (SUS).

A saúde suplementar engloba os planos de saúde, muitas pessoas vêm a confundir planos de saúde com seguro de saúde, cabe destacar a diferença existente entre esses seguimentos:

- Plano de saúde – tendo em vista que o SUS não supri as necessidades de toda população e que consultas médicas, estadia hospitalar e laboratorial são caros. Os planos de saúde vieram para suprir essa necessidade, onde ele oferece serviços tanto próprios quanto de lugares conveniados com relação a atendimentos médicos, hospitalares e laboratoriais. Além disso, existem planos que oferecem a garantia de reembolso.

1º Além disso, os planos de saúde abrangem modalidades que podem ser escolhidas pela pessoa que irá ingressar nessa atividade, por exemplo: plano individual, plano familiar, plano empresarial.

- Seguro saúde – ao contrário do plano de saúde, o seguro saúde é um contrato que garante ao seu segurado o reembolso por todas as consultas médicas, exames, tratamentos, entre outros, que está assegurado no contrato pré-estabelecido. Desta forma, ao contrário do plano de saúde, o seguro saúde não oferece os profissionais que o segurado deve escolher para realizar seu tratamento ou laboratórios, mas sim, deixa a cargo da pessoa escolher, devendo seguir todos os requisitos para receber o reembolso de acordo com o plano que foi contratado.

2º A Lei nº9656/98 traz em seu texto que são distribuídos em síntese no Brasil os planos e seguros com atendimento ambulatorial, hospitalar, que engloba em conjunto o hospitalar e o ambulatorial, os que incluem a obstetria e

os que não incluem, e, inclusive aqueles que incluem os serviços odontológicos. São as pessoas beneficiárias que escolhem seus planos ou seguros como preferir.

No Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar de dezembro de 2009 a dezembro de 2019 o número de beneficiários aumentou de 42.561.398 para 47.095.095, são quase 5 milhões de pessoas a mais com planos privados de saúde. Tornando esses números em percentual com relação a população brasileira, a ANS traz a seguinte tabela, demonstrada na figura 1 a seguir:

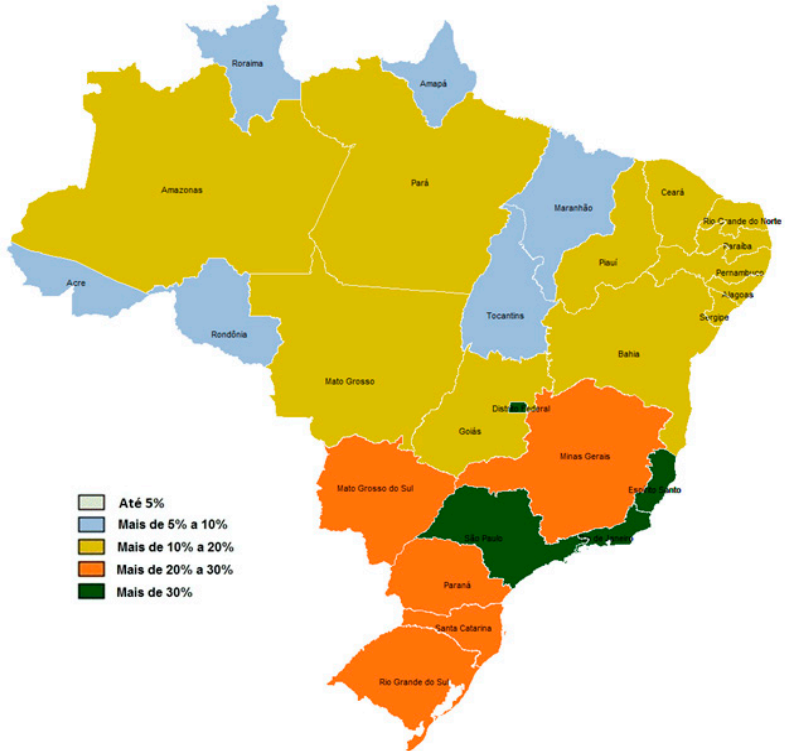
Tabela 1 - Taxa de cobertura (%) por planos privados de saúde (Brasil - 2009-2019)

| Ano       | Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia | Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dez /2009 | 22,1                                                                          | 6,9                                                           |
| Dez /2010 | 23,6                                                                          | 7,6                                                           |
| Dez /2011 | 23,9                                                                          | 8,5                                                           |
| Dez /2012 | 24,6                                                                          | 9,5                                                           |
| Dez /2013 | 25,4                                                                          | 10,0                                                          |
| Dez /2014 | 26,0                                                                          | 10,2                                                          |
| Dez /2015 | 25,5                                                                          | 10,7                                                          |
| Dez /2016 | 24,6                                                                          | 10,9                                                          |
| Dez /2017 | 24,3                                                                          | 11,4                                                          |
| Dez /2018 | 24,3                                                                          | 12,5                                                          |
| Nov /2019 | 24,3                                                                          | 13,3                                                          |

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS e População - IBGE/Datasus

Além disso, a ANS coletou dados de novembro de 2019 onde consta que nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no Distrito Federal os percentuais de adeptos ao plano de saúde são maiores, vejamos na figura 2:

Figura 2 - Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por Unidades da Federação (Brasil - Novembro/2019)



Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS - 11/2019 e População - IBGE/DATASUS/

## Problema com o SUS

O número de pessoas que possuem plano de saúde vem aumentando cada vez mais devido a insatisfação da população com o SUS, pois, mesmo a Constituição Federal garantindo a todos o direito a saúde, o SUS enfrenta problemas com a falta de médicos, que, segundo dados do Conselho Federal de Medicina, para cada médico há cerca de 470 brasileiros, isso segundo dados nacionais, analisando por regiões, no norte chega a ser um médico para 953,3 pessoas.

Outro problema do SUS é a longa espera para marcar consultas e exames, o Brasil registrou no ano de 2016, segundo dados da Fisc Saúde uma média de 2,8 consultas por habitante. Quando se fala em consulta com especialista, exames ou até mesmo cirurgias, muitos são os relatos de pessoas que passam cerca de 6 meses na fila ou até mais tempo, e, quando conseguem sua vaga, ao chegarem no hospital se deparam com a superlotação e pacientes nos corredores.

Segundo o Conselho Federal de Medicina, o que poderia fazer melhorar a saúde pública seria o aumento no número de leitos. A OMS recomenda que o país tem que ter entre 3 a 5 mil leitos por mil habitantes, o Brasil, todavia, só tem 2,3 leitos por mil habitantes.

Do orçamento público federal, apenas 3,6% é destinado ao SUS e uma emenda à Constituição aprovada em 2016 congelou o aumento nos gastos públicos durante 20 anos. Além disso, os maiores escândalos de roubo dos políticos vêm do dinheiro destinado a saúde, o que faz o que já é pouco se tornar ainda menos.



Fonte: @freepik

Apesar das inúmeras dificuldades, é válido dizer que o SUS vem crescendo. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, o Sistema Único de Saúde realiza por ano mais de 1,5 milhões de cirurgias efetivas, de 12 milhões de internações e chega ao marco de 4,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais.

# A lei nº9961/2000 – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)



## OBJETIVO

Ao término desse capítulo você será capaz de entender toda a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, todas as suas competências e como ela deve agir com relação a saúde suplementar. Vamos lá..

Como mencionado anteriormente, com o advento da Lei nº 9656/98, no ano 2000, como complementação desta lei, foi sancionada a Lei nº9961 que trouxe a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Antes da sanção dessa lei, os planos e os seguros de saúde por não terem sua legislação, seguiam os parâmetros determinados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), mas funcionando por sua própria vontade, o que não continha seu comportamento, oferecendo garantias aos beneficiários e poucos direitos, como por exemplo, os planos tinham liberdade para delimitar o prazo máximo que os beneficiários podiam ficar internados e prolongavam o período de carência, o que fez na época surgir vários planos que coletavam o dinheiro dos beneficiários no período de carência e posteriormente desapareciam, deixando seus adeptos sem resposta. Além disso, excluía cobertura de doenças importantes, escolhiam sua clientela e podiam fazer rescisão unilateral dos contratos.

A Lei nº 9656/98, antes mesmo do surgimento da ANS para garantir os direitos dos beneficiários e maior segurança, já trouxe em seu art. 8º um rol de requisitos que devem ser cumpridos pelas operadoras de planos privados para obter a autorização de funcionamento. Esse rol independe dos que a ANS também determina, sendo eles:

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de

outros que venham a ser determinados pela ANS: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980;

II - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a serem prestados por terceiros;

III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de serviços;

IV - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria;

V - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados;

VI - demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras;

VII - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde.

§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º do art. 1º. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos,

independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (Brasil,1998)

Com esses requisitos a serem preenchidos para obter a autorização de funcionamento, já diminuiu a quantidade de golpes dados pelos planos privados de assistência à saúde.

O Estado é responsável pela saúde, pois esta é considerada um bem público, viu então que era de sua obrigação estabelecer regras e regular a saúde suplementar. Desta forma, e com amparo na Lei ° 9656/98 criou a ANS.

Com o surgimento da ANS, como agência reguladora dos planos de saúde, houve a consolidação do controle desses fatos, estabelecendo que se um beneficiário precisar ser internado, não poderá ser estabelecido limite de dias para sua internação, além disso, foi padronizado o período de carência dos planos, completando a Lei nº9656.



### **IMPORTANTE**

A prioridade da ANS é defender todos os consumidores dos planos de saúde.

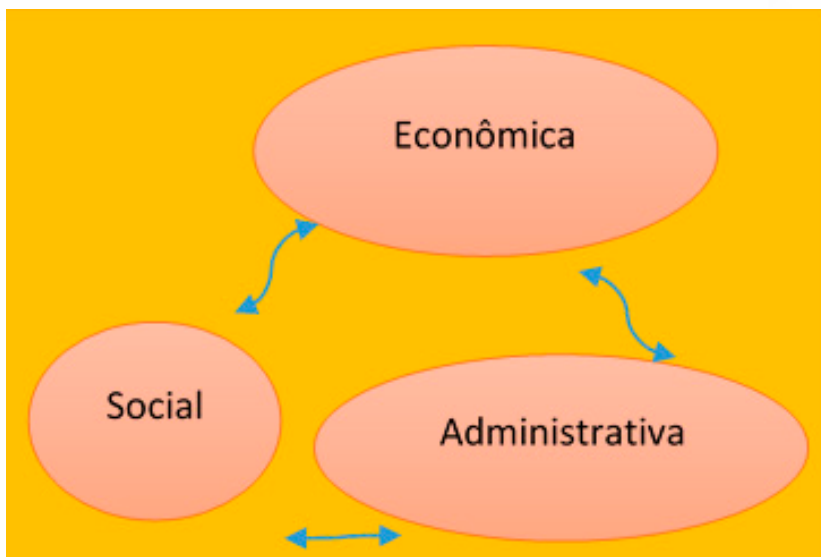
A Lei nº 9961/2000 trata da finalidade, competência, estrutura organizacional, patrimônio, receita, gestão financeira, entre outras coisas, da ANS.

As agências reguladoras têm três características principais:

- Tem estabelecido por lei um poder regulador, podendo desta forma controlar, fiscalizar, regular e além disso, punir.
- Possui autonomia administrativa, tendo seus dirigentes mandatos e possui flexibilidade nos recursos humanos, em sua estrutura organizacional, ou seja, nos seus instrumentos de gestão
- Além de autonomia administrativa, possui autonomia financeira, podendo arrecadar de forma direta suas taxas.

Além disso, a regulação pode ser de três tipos. Vejamos na figura 4

Figura 4 – Tipos de regulação



Fonte: Elaborado pela autora (2020)

A regulamentação econômica tem como principal objetivo facilitar, intensificar ou limitar o movimento do mercado, inserindo tarifas, além de

princípios de confiabilidade do serviço público e ainda regras de entrada e saída do mercado, propiciando dessa forma, a estrutura institucional para os agentes econômicos, empresas e mercados.

A regulamentação social é aquela que interfere nos bens públicos e na proteção do interesse público, sendo incumbido de definir os padrões para a saúde, meio ambiente e segurança e de como será oferecido esses bens.

Por fim, a regulamentação administrativa é a que interfere nos procedimentos administrativos e que possuem caráter burocrático, como também nos processos administrativos que são adotados pelo Poder Público quando se envolvem com os administradores.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, como agência regulamentar é vinculada ao Ministério da Saúde, sendo subordinado a orientação do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), integrando o Ministério. Para que possa atuar, a ANS firma um Contrato de Gestão com o Ministério que tenha sido aprovado pelo CONSU, devendo ser acompanhado por uma Comissão de Acompanhamento que deverá conter como um dos seus integrantes o Ministério do Planejamento e Orçamento.

O **Contrato de Gestão** da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem o objetivo de pactuar com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, compromissos e resultados mediante o estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e indicadores. O contrato constitui instrumento de controle social e de avaliação e aperfeiçoamento da gestão e do desempenho da ANS. (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2000)

Desta forma, como agência reguladora que é, a ANS goza das mesmas prerrogativas que são atribuídas ao novo modelo de Estado, sendo elas:

- Maior poder de atuação
- Arrecadação própria, possuindo assim autonomia política, financeira e administrativa
- Decisões em Diretoria Colegiada
- Poder legal para efetivação de suas resoluções

Apesar das agências reguladoras em seu sentido seja subordinada, a ANS possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, isto porque, acredita-se que mais importante do que a autonomia é a transparência nas decisões e sua prestação de conta. Assim, sendo independente a ANS evita que haja interferência política na análise técnica dos custos privados e dos benefícios.

Observa-se a independência da Agência Nacional de Saúde Suplementar ao notar que não necessita do Poder Legislativo, pois ela mesmo que edita suas normas, todavia, as normas elaboradas pela ANS não podem ser conflitantes com as normas do ordenamento jurídico; não necessita do Poder Executivo, pois suas decisões já possuem caráter definitivo; como podem solucionar litígios que envolvem a atividade reguladora e o segmento regulador, não necessita do Poder Judiciário.

Em seu art. 3º, a Lei nº 9961/2000 traz a finalidade da ANS, que é de promover a defesa do interesse público no que se refere a assistência suplementar, devendo regular as operadoras setoriais e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde.

O art.4º traz um rol taxativo da competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

Art. 4º Compete à ANS:

I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;

II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras;

III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades;

IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;

V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras;

VI - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS;

VII - estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;

VIII - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;

IX - normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;

X - definir, para fins de aplicação da Lei nº 9.656, de 1998, a segmentação das operadoras e administradoras de planos privados de assistência à saúde, observando as suas peculiaridades;

XI - estabelecer critérios, responsabilidades, obrigações e normas de procedimento para garantia dos direitos assegurados nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

XII - estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.656, de 1998;

XIII - decidir sobre o estabelecimento de sub-segmentações aos tipos de planos definidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998;

XIV - estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos das operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XV - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles próprios, referenciados, contratados ou conveniados;

XVI - estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

XVIII - expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões;

XIX - proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde;

XX - autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde;

XXI - monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus prestadores de serviços, e respectivos componentes e insumos;

XXII - autorizar o registro e o funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem assim sua cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994;

XXIII - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento;

XXIV - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XXV - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras

de planos privados de assistência à saúde para garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis na área geográfica de abrangência;

XXVI - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos;

XXVII - fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da legislação referente aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;

XXVIII - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XXIX - fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei nº 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;

XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei nº 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;

XXXI - requisitar o fornecimento de informações às operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como da rede prestadora de serviços a elas credenciadas;

XXXII - adotar as medidas necessárias para estimular a competição no setor de planos privados de assistência à saúde;

XXXIII - instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras;

XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a requerer a falência ou insolvência civil das operadoras de planos privados de assistência à saúde; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados de assistência à saúde das operadoras; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

XXXVI - articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar;

XXXVIII - administrar e arrecadar as taxas instituídas por esta Lei.

XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus cumprimentos; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

XL - definir as atribuições e competências do Diretor Técnico, Diretor Fiscal, do liquidante e do responsável pela alienação de carteira. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso e o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

a) conteúdos e modelos assistenciais; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

b) adequação e utilização de tecnologias em saúde; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

c) direção fiscal ou técnica; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

d) liquidação extrajudicial; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

f) normas de aplicação de penalidades; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos comercializados ou disponibilizados; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

XLII - estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 1º A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível com multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser aumentada em até vinte vezes, se necessário, para garantir a sua eficácia em razão da situação econômica da operadora ou prestadora de serviços. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2º As normas previstas neste artigo obedecerão às características específicas da operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos. (Brasil, 2000)

No Capítulo II da Lei nº9961/2000 consta a estrutura organizacional da ANS, que será dirigida por uma Diretoria Colegiada, precisando também ter em sua estrutura um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor. Devendo além disso, ter uma Câmara de Saúde Suplementar, que deverá ser de caráter permanente e consultivo.

A Resolução Regimental nº1 de 17 de março de 2017 da ANS, em seu art. 2º traz a estrutura básica que a agência tem, sendo:

- Diretoria Colegiada – DICOL;
- Presidência – PRESI
- Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES

- Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE
- Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DI-PRO
- Diretoria de Fiscalização – DIFIS
- Diretoria de Gestão – DIGES
- Secretaria Geral da Diretoria Colegiada – SEGER
- Procurador Federal junto à ANS – PROGE
- Ouvidoria – OUVID
- Corregedoria – PPCOR
- Auditoria Interna – AUDIT
- Câmara de Saúde Suplementar – CAMSS
- Comissão de Ética - CEANS

## Estrutura Básica da ANS

Como já mencionado, a Resolução Regimental nº1 de 17 de março de 2017 da ANS, em seu art. 2º traz a estrutura básica que a ANS tem, desta forma, devemos estudar a competência de cada órgão participante dessa estrutura. Pontuaremos cada órgão que compõe a estrutura com a sua competência a seguir:

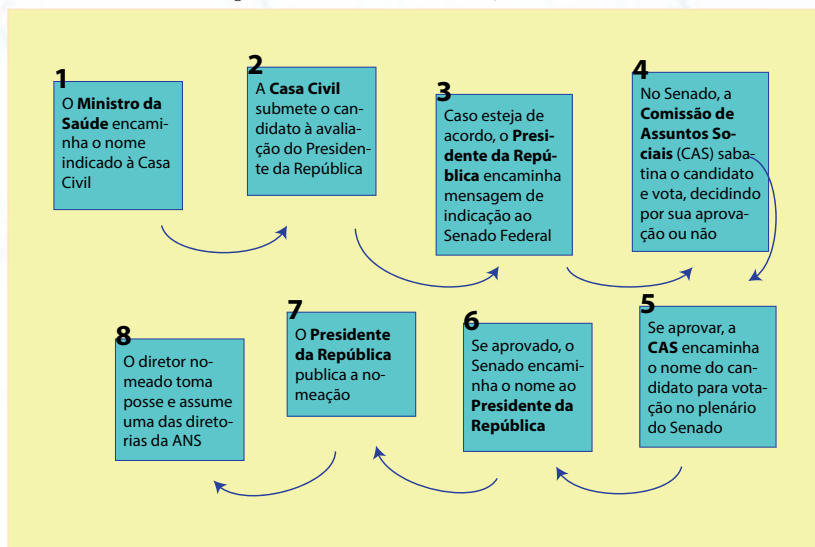


Fonte: @freepik

- **Diretoria Colegiada**

A Diretoria Colegiada deve ser composta por cinco diretores, em que um deles será nomeado o presidente, devendo os cinco serem brasileiros, indicados pelo Presidente da República, devendo ser aprovados pelo Senado Federal e por fim, nomeados (figura 5) pelo Presidente para que possa exercer um mandato de cinco anos sem poder exercer um novo mandato. O Presidente da República que escolhe aquele que vai vir a ser o Diretor-Presidente entre os cinco que foram nomeados para exercer o mandato.

Figura 5 – Processo de Nomeação do Diretor



Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Após acabar o mandato ou deixar o cargo, os ex-diretores não poderão pelo prazo de doze meses, nos moldes do art. 9º da lei em estudo:

- Representar qualquer interesse ou pessoa perante a ANS, com exceção dos seus próprios interesses relacionados a contrato particular de assistência à saúde suplementar, sendo tanto na condição de contratante como na de consumidor.
- Não poderá participar, exercer cargo ou qualquer função em qualquer organização que esteja sujeita à regulamentação da ANS.

Logo em seguida, o art. 10, traz as competências da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que deve se reunir com a presença de pelo menos três diretores, devendo está presente o Diretor-Presidente ou que ele determine seu substituto legal, devendo decidir com no mínimo três votos iguais. As competências da Diretoria são:

- Administrar a ANS

- Editar as normas que são de matérias competentes da ANS
- Definir a área de atuação de cada diretor
- Aprovar o regimento interno da ANS
- Tem o dever de cumprir e de garantir que sejam cumpridas as normas que dizem respeito a saúde suplementar
- No que tange as suas atividades, deve elaborar e divulgar relatórios periódicos
- Quando houver recurso por provocação dos interessados sobre decisões dos Diretores, a Diretoria Colegiada que o deve julgar
- Encaminhar as comprovações de toda contabilidade da ANS aos órgãos competentes.

O Diretor-Presidente tem competências exclusivas, sendo elas de representar a ANS legalmente; deve presidir as reuniões da Diretoria; devendo cumprir e fazendo com que todos cumpram as decisões tomadas pela Diretoria Colegiada; quando houver questões de urgência da Diretoria, é o Diretor-Presidente que deve decidir; quando houver empate nas deliberações da Diretoria Colegiada, deverá ele decidir; contratar as pessoas para cargos efetivos, podendo ser em comissão e função de confiança, possuindo o papel de nomear e exonerar os servidores, exercendo no que couber o poder disciplinar; encaminhar para o Ministério da Saúde e para o CONSU os pareceres elaborados pela Diretoria Colegiada; deve assinar os contratos e os convênios da ANS, ordenando as despesas e praticando os atos necessários para a gestão.

---

### **IMPORTANTE**



Na hora de se manifestar os instrumentos utilizados pela DICOL são: ata, resolução (normativa, normativa conjunta, operacional, administrativa e regimental), súmula normativa, portaria, consulta pública, comunicado e despacho. Devendo cada ato ser expedido pelo Diretor-Presidente ou seu substituto legal.

---

- **Diretoria de Desenvolvimento Setorial**

No que se refere a competência da DIDES, o art 8º da Resolução Regimental nº1 da ANS, traz:

Art. 8º À Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES compete:

I - exercer as atribuições referentes a integração e disseminação de informações setoriais, relacionamento entre prestadores de serviços de saúde e operadoras, ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, bem como a melhoria do desempenho das operadoras e incentivo à qualidade na Saúde Suplementar;

II - identificar interfaces e fomentar a integração entre o sistema de Saúde Suplementar e o Sistema Único de Saúde;

III - organizar e analisar as medidas de vigilância epidemiológica de saúde no âmbito da Saúde Suplementar;

IV - estudar e propor modelos assistenciais na prestação dos serviços de saúde com vistas ao desenvolvimento do setor de Saúde Suplementar, sem prejuízo das atribuições da DIPRO;

V - fomentar a estruturação de Redes de Atenção à saúde na Saúde Suplementar, sem prejuízo das atribuições da DIPRO;

VI - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras, sem prejuízo das atribuições da DIPRO;

VII - incentivar a melhoria da qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar;

VIII - disseminar boas práticas de gestão setorial;

IX - planejar e coordenar as atividades de acreditação das operadoras de planos de assistência à saúde e de qualificação da rede prestadora de serviços;

X - buscar o desenvolvimento sustentável e a garantia de competição no setor de planos privados de assistência à saúde;

XI - articular-se com as demais Diretorias para a definição dos sistemas de informações da ANS;

XII - exercer as atribuições relacionadas à padronização e implementação de trocas de informações, referentes aos eventos de atenção à saúde, e ao Registro Eletrônico em Saúde, no âmbito da Saúde Suplementar;

XIII - pesquisar, estudar e avaliar os mecanismos de desenvolvimento institucional e de desenvolvimento e gestão de sistemas de informação no mercado nacional e internacional, aplicados para uso na ANS;

XIV - articular com os órgãos centrais e setoriais de administração de recursos de informação do Governo Federal, com vistas à implantação de Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico e a integração e intercâmbio de dados e sistemas;

XV - promover a articulação com organismos nacionais, internacionais ou multilaterais para cooperação técnica e financeira tendo em vista o aprimoramento do setor;

XVI - promover a articulação com as demais Diretorias e supervisionar a execução do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar no que compete ao componente da Qualificação Operadoras, sem prejuízo das atribuições da DIGES;

XVII - participar da elaboração da proposta de Política de Segurança da Informação da ANS, sem prejuízo das atribuições da DIGES;

XVIII - promover e coordenar a gestão estratégica da Política de Informação na ANS, visando o desenvolvimento setorial;

XIX - criar e gerir a Sala de Situação da ANS, com o objetivo de formular diretrizes para tomada de decisões no setor de saúde suplementar;

XX - encaminhar à DIFIS, através da DIRAD e/ou seus órgãos regimentados, comunicação acerca de indícios de infração por

descumprimento da legislação de saúde suplementar, para apuração e aplicação das penalidades cabíveis, ressalvadas as hipóteses previstas no inciso XXI deste artigo;

XXI - instaurar e instruir os processos administrativos para apuração de indícios de infrações às disposições legais ou infra legais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar cujo monitoramento, análise ou solicitação sejam relacionados às suas competências;

XXII - promover a Política Nacional de Segurança do Paciente no âmbito da saúde suplementar;

XXIII - planejar e coordenar as atividades relativas à implementação, à manutenção, ao monitoramento e ao aperfeiçoamento do cadastro de beneficiários da Saúde Suplementar;

XXIV - efetuar estudos e propor normas referentes aos aspectos econômico-financeiros dos mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde adotados e utilizados pelas operadoras de planos de assistência à saúde;

XXV - indicar os aspectos econômico-financeiros referentes à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à saúde, de fator moderador como mecanismo de regulação no uso dos serviços de saúde. (Brasil, 2017)



### **NOTA**

Deste modo, de forma geral é a DIDES que aprimora a relação entre a operadora e as prestadoras de serviço de saúde, e mantém a relação entre o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar.

---

- **Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras**

Nessa mesma resolução em seu art. 9º tem o rol das competências da DIOPE, sendo: planejamento das atividades exercidas por suas Gerências-Gerais, assim como propor diretrizes para a saúde suplementar sobre constituição, organização, funcionamento, qualificação e parâmetros de capital e patrimônio líquido das operadoras, contabilidade, estatísticas e dados atuariais, estes referentes às reservas e provisões das operadoras, critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro consistente em bens, móveis e imóveis, ou fundos especiais ou seguros garantidores, criação de fundos, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de insolvência das operadoras, procedimentos de adequação econômico-financeira das operadoras, regimento especial de direção fiscal e de liquidação extrajudicial nas operadoras.

Também compete ao DIOPE outorgar e cancelar o registro e a autorização de funcionamento das operadoras, autorizar a cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário das operadoras, planejar e coordenar as atividades de qualificação das operadoras de planos de saúde, inabilitar o exercício de cargos diretivos nas operadoras, aprovar as propostas de saneamento apresentadas pelas operadoras no curso do regime de direção fiscal, proferir decisões no âmbito dos Procedimentos de Adequação Econômico-financeira, informar a DICOL, quadrimestralmente, ou quando solicitado, as decisões proferidas nos Procedimentos de Adequação Econômico-financeira das operadoras no período, elaborar relatórios estatísticos setoriais da saúde suplementar no âmbito de suas atribuições, desenvolver e manter, em consonância com as demais áreas competentes, sistemas de informações compreendendo dados cadastrais e econômico-financeiros das operadoras, propor projetos de estudo e desenvolvimento do mercado, podendo servir-se de apoio técnico das demais gerências da ANS, sobre os assuntos de sua competência, propor a instauração de Câmaras Técnicas sobre os assuntos de sua competência, aprovar os TAO – Termos de Assunção de Obrigações apresentados pelas operadoras sobre os assuntos de sua competência, representar a ANS

junto a organizações sociais e internacionais que estudam assuntos afetos à sua área e ao mercado de saúde suplementar, em especial os Sub-Comitês da International Association of Insurance Supervisors – IAIS, encaminhar a DIFIS, através da DIRAD e/ou suas gerências, comunicação acerca de indícios de infração por descumprimento da legislação de saúde suplementar, para apuração e aplicação das penalidades cabíveis e, instaurar e instruir os processos administrativos para apuração de indícios de infrações às disposições legais ou infra legais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar cujo monitoramento, análise ou solicitação sejam relacionados às suas competências.

- **Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos**

Já no que se refere a competência da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO, o art. 10 da Resolução traz:

Art. 10. À Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO compete:

I - planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades de regulamentação, habilitação, qualificação e acompanhamento dos produtos ou planos privados de assistência à saúde;

II - monitorar a evolução dos preços de produtos ou planos privados de assistência à saúde, prestadores de serviços e insumos;

III - certificar produtos das operadoras, conforme o nível de habilitação assistencial e gerencial;

IV - efetuar estudos e propor normas referentes a reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde;

V - efetuar estudos e propor normas referentes a mecanismos de regulação assistencial do uso dos serviços de saúde adotados e utilizados pelas operadoras de planos de assistência à saúde;

VI - efetuar estudos e propor normas referentes a rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e cancelamento

do registro dos produtos ou planos privados de assistência à saúde definidos no inciso I e no §1º do Art. 1º da Lei nº 9.656, de 1998;

VII - efetuar estudos e propor normas referentes a conceitos e os procedimentos referentes às doenças e lesões preexistentes e suas implicações;

VIII - efetuar estudos, propor normas e realizar o monitoramento referentes aos aspectos assistenciais dos produtos ou planos privados de assistência à saúde, de beneficiários ativos e inativos, em especial em relação aos modelos assistenciais, às garantias de acesso e cobertura de procedimentos, às carências para acesso e sua portabilidade;

IX - indicar características gerais dos instrumentos contratuais utilizados pelas operadoras de planos de assistência à saúde com os contratantes de plano de saúde pessoas físicas ou jurídicas;

X - estabelecer parâmetros e propor diretrizes referentes a programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças;

XI - elaborar e publicar anuário e guias de produtos;

XII - desenvolver e manter, em conjunto com a área específica da ANS, sistemas de informações compreendendo dados econômico-financeiros e assistenciais dos produtos oferecidos e mantidos pelas operadoras setoriais;

XIII - constituir e coordenar grupos técnicos ou câmaras técnicas para discussão de temas relacionados às competências da Diretoria;

XIV - elaborar e propor o rol de procedimentos e eventos em saúde;

XV - elaborar e propor critérios de incorporação de tecnologias em saúde adotadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XVI - sugerir indicadores para avaliação, monitoramento e divulgação do perfil da organização e produção de ações e serviços de saúde pelas operadoras;

XVII - elaborar e propor critérios de migração e adaptação de contratos celebrados antes de 10 de janeiro de 1999;

XVIII - supervisionar o processo de alienação de carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XIX - autorizar a alienação e transferência das carteiras de planos privados de assistência à saúde das operadoras, na forma da regulamentação em vigor;

XX - propor diretrizes para instauração do regime especial de Direção Técnica e alienação de carteira;

XXI - elaborar e propor critérios de incorporação de tecnologias em saúde adotadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XXII - promover visitas técnicas com vistas ao acompanhamento e verificação das informações encaminhadas à ANS, no âmbito de sua competência;

XXIII - propor à Diretoria Colegiada da ANS, a instauração do Regime Especial de Direção Técnica e Alienação de Carteira, conforme o disposto no Art. 24 da Lei nº 9.656, de 1998;

XXIV - aprovar ou rejeitar o Plano de Recuperação Assistencial apresentado pela operadora de planos privados de assistência à saúde;

XXV - acompanhar o Programa de Saneamento Assistencial apresentado pela operadora de planos privados de assistência à saúde, podendo fazer considerações para o melhor desenvolvimento da Direção Técnica;

XXVI - encaminhar à DIFIS, através da DIRAD e/ou suas gerências, comunicação acerca de indícios de infração por descumprimento da legislação de saúde suplementar, para

apuração e aplicação das penalidades cabíveis, ressalvadas as hipóteses previstas no inciso XXVII deste artigo;

XXVII - instaurar e instruir os processos administrativos para apuração de indícios de infrações às disposições legais ou infra legais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar cujo monitoramento, análise ou solicitação sejam relacionados às suas competências;

XXVIII - elaborar e propor normas visando à garantia e à manutenção de todos os benefícios de acesso à cobertura previstos na Lei nº 9.656, de 1998 e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no Art. 12 da referida lei, prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras e planos privados de assistência à saúde; e

XXIX - estabelecer critérios para a aferição da capacidade técnico- operacional das operadoras quanto à efetiva garantia de todos os benefícios de acesso à cobertura previstos na Lei nº 9.656, de 1998 e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no Art. 12 da referida lei, em especial quanto às redes assistenciais. (Brasil, 2017)

- **Diretoria de Fiscalização**

É de competência da DIFIS – Diretoria de Fiscalização fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento, fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei nº9656/98, instaurar, instruir e decidirem primeira instância os processos administrativos destinados à apuração de infrações aos dispositivos legais ou infra legais disciplinadores do mercado de saúde suplementar, bem como aplicar as correspondentes penalidades, se for o caso, excetuados os que tenham por objetivo o não envio ou envio irregular das informações ou dos documentos obrigatórios, cuja decisão poderá ser delegada a outros agentes ou órgãos da ANS, promover a articulação com os órgãos e entidades

integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e da sociedade civil organizada, inclusive ações de cooperação técnica, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços de assistência suplementar à saúde, planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades da Central de Relacionamento da ANS, e gerenciar o serviço do Disque ANS, planejar, controlar, coordenar, organizar e executar as ações de fiscalização da ANS, promover medidas que visem à mediação ativa de interesses entre os agentes regulados, com vistas à solução consensual dos casos de conflito, desenvolver, manter e executar, em articulação com as demais Diretorias, sistema de informações que contenha informações e dados das atividades de fiscalização, compreendendo demandas oriundas de beneficiários, operadoras, prestadores de serviços e demais interessados do mercado de saúde suplementar, definir as operadoras a serem objeto de intervenção fiscalizatória, conforme regulamentação específica, propor a instauração de Câmaras Técnicas sobre os assuntos de sua competência, uniformizar entendimentos, a vigorarem no âmbito da DIFIS, sobre a aplicação da legislação atinente ao mercado de saúde suplementar, a configuração de infração à legislação dos planos privados de assistência à saúde e seus regulamentos, bem como sobre a aplicação da correspondente sanção, exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar seu cumprimento, supervisionar, coordenar e controlar as ações dos Núcleos da ANS relacionadas ao exercício das atividades de fiscalização, promover a especial designação dos agentes que exercerão as atividades de fiscalização da ANS, estabelecendo os limites de tal exercício, indicar à Diretoria Colegiada da ANS a nomeação dos Chefes

dos Núcleos da ANS. Todas essas competências conforme , o art 11 da Resolução Regimental nº1 da ANS.

- **Diretoria de Gestão**

No que tange a competência da Diretoria de Gestão – DIGES nos moldes do art. 12 da Resolução em estudo possui a competência de promover, planejar, coordenar, supervisionar, propor normas e avaliar a execução das atividades referentes à: política de gestão de pessoas, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, política de gestão do conhecimento, qualificação institucional, implantação e implementação de ferramentas de gestão, gestão documental, licitação e macrogestão de contratos, orçamento, finanças e contabilidade pública logística e administração de material e serviços e governança da tecnologia da informação, relativa à: 1. sustentação operacional de Tecnologia da Informação – TI, 2. arquitetura tecnológica e de sistemas; 3. gestão da informação, 4. segurança da informação, 5. gestão de projetos de TI e 6. prospecção tecnológica. Compete também a DIGES planejar, controlar, orientar, avaliar e supervisionar as atividades por suas Gerências-Gerais e Assessoria Normativa, propor diretrizes para o aprimoramento da gestão da ANS, bem como coordenar e apoiar as atividades de organização e modernização da gestão relativas aos projetos e processos internos de gestão e a definição de diretrizes de inovação gerencial, inclusive as relacionadas com os sistemas federais de administração de pessoal, de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de administração financeira e de processos licitatórios para contratação de bens e serviços; promover a articulação com os órgãos e entidades da estrutura do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda para realização das atividades de competência da Diretoria, as áreas técnicas de outros órgãos, visando acompanhar os assuntos ligados à saúde suplementar, as demais Diretorias para o desenvolvimento e implantação de ferramentas de gestão e execução do Programa de Qualificação Institucional.

Também é de competência da DIGES incentivar a melhoria da qualidade dos processos e disseminar as boas práticas de gestão na ANS; propor, incentivar e supervisionar a implantação e implementação

de ferramentas de gestão; estudar, planejar, propor, promover, avaliar e supervisionar os mecanismos de qualificação Institucional e a execução do Programa de Qualificação Institucional; propor, fomentar, planejar, coordenar e avaliar a política da qualidade na gestão e da gestão do conhecimento da ANS, a contratação e execução de estudos e pesquisa de interesse da ANS, os projetos de pesquisa, através de cooperação técnica-científica nacional e internacional, no âmbito da saúde suplementar, a política de gestão de documentos da ANS, as atividades relacionadas à capacitação e desenvolvimento de pessoas, o programa de educação permanente, o planejamento e acompanhamento de atividades do Contrato de Gestão, ou outro instrumento de acompanhamento que venha a ser adotado, dando ciência à Diretoria Colegiada da ANS e a política de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no âmbito da ANS; estudar, analisar e avaliar os mecanismos de desenvolvimento de pessoas e de gestão, existentes no mercado nacional e internacional, aplicados para uso na ANS; coordenar, supervisionar e controlar a elaboração e o acompanhamento do orçamento, em conjunto com a SEGER e executá-lo, e as atividades administrativas e de gestão realizadas nos Núcleos da ANS; acompanhar a execução das atividades de finanças, material e patrimônio e serviços gerais, inclusive de forma descentralizada, a arrecadação da Taxa de Saúde Suplementar, as retribuições por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros, inclusive as doações, legados, subvenções e outros recursos que forem destinados a ANS, de acordo com a legislação vigente o processo de prestação de contas anual da ANS, junto aos órgãos central e setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e a elaboração de planos integrados de melhoria de operação e suas ações visando a modernização dos sistemas administrativos; encaminhar à DIFIS, através da DIRAD/DIGES e/ou suas gerências, comunicação acerca de indícios de infração por descumprimento da legislação de saúde suplementar, para apuração e aplicação das penalidades cabíveis; propor, definir e promover as diretrizes de segurança e tecnologia da informação e gestão estratégica da Tecnologia da Informação na ANS; instaurar e instruir os processos administrativos para apuração de indícios de infrações às disposições legais ou infra legais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar

cujo monitoramento, análise ou solicitação sejam relacionados às suas competências.



### IMPORTANTE

Todas as diretorias têm comum atribuição de expedir atos de instrução normativa, atos de requisição de informações, atos de convocação, podem participar com direito a voto das reuniões e circuitos deliberativos, decidir sobre as matérias que afetam a sua diretoria, com ressalva das reservadas a DICOL, que neste caso caberá recurso, pode também, encaminhar proposta de ato normativo no âmbito de sua competência à DICOL e, por fim, podem firmar termo de compromisso.

#### • **Secretaria Geral da Diretoria Colegiada**

Quanto a SEGER, tratada no art. 13 da resolução sua competência, de maneira geral, ela é responsável por coordenar as atividades e os projetos que são determinados pela Diretoria Colegiada, como por exemplo, a definição das pautas da DICOL, além disso, deve supervisionar e acompanhar o Contrato de Gestão, coordenar também, as atividades de planejamento, de comunicação social e da Agenda Regulatória da ANS, acompanhar as principais informações gerenciais das Diretorias da ANS. Tem como suas subordinadas: a Unidade de Gerência de Planejamento, Gerência de Comunicação Social, as Coordenadorias de Apoio à Diretoria Colegiada, de Recursos da Diretoria Colegiada, de Inquéritos e a Secretária-Executiva de Comissão de Ética e Núcleos da ANS.

#### • **Procuradoria Federal junto à ANS e Ouvidoria**

Os arts.14 e 15 da Resolução Regimental nº1 de 17 de março de 2017 da ANS, tratam das competências da PROGE e da OUVID, sendo elas:

Art. 14 À Procuradoria Federal junto à ANS - PROGE, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal - PGF, compete:

I - representar a ANS em juízo ou fora dele;

II - assistir à DICOL e aos Diretores, exercendo as atividades de consultoria e assessoramento jurídico;

III - desistir, transigir e firmar compromisso nas ações de interesse da ANS, ouvida previamente a DICOL;

IV - analisar e opinar sobre os assuntos de natureza jurídica, bem como examinar previamente os atos normativos a serem editados pela ANS;

V - assistir às Diretorias e aos demais órgãos integrantes da estrutura organizacional da ANS no controle interno da legalidade dos atos a serem praticados ou já efetivados;

VI - propor a declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da ANS quando editados com vício;

VII - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da ANS, tributária ou de qualquer natureza, para fins de inscrição e cobrança amigável ou judicial;

VIII - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Procurador-Geral Federal ou do Advogado-Geral da União;

IX - articular-se com os demais órgãos da PGF e da Advocacia-Geral da União - AGU;

X - coordenar, promover e supervisionar as atividades de comunicação entre os órgãos da ANS e os órgãos da PGF e da AGU, quanto aos elementos de fato e de direito, necessários para a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses da ANS;

XI - receber e expedir respostas elaboradas pela ANS às denúncias, consultas e requisições formuladas pelo Poder Judiciário, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, órgãos da Advocacia Geral da União, Procuradorias Gerais Estaduais e Municipais, Polícia Federal, Polícias Cíveis Estaduais, bem como encaminhar, quando solicitado, outros expedientes produzidos pela Agência a esses órgãos públicos, sem prejuízo das atribuições dos Núcleos e da COINQ.

§1º As atribuições da Procuradoria constantes desta resolução serão exercidas nos limites estabelecidos nos atos normativos da PGF e da AGU.

§2º Sem prejuízo das competências exercidas pelas Gerências e Assessorias que integram a PROGE, o Procurador-Chefe poderá designar, por meio de Portaria, Procurador Federal para exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos junto a uma Diretoria específica.

§3º Os pareceres e demais pronunciamentos jurídicos dos procuradores federais em exercício na Procuradoria Federal junto à ANS serão aprovados pelo Procurador-Chefe, exceto quando se tratar de manifestação jurídica para apurar a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida ativa da ANS, tributária ou de qualquer natureza, para fins de inscrição e cobrança, amigável ou judicial, emitindo manifestação jurídica.

Art. 15. À Ouvidoria - OUVID compete:

I - acompanhar e avaliar permanentemente a atuação da ANS, recomendando, quando couber, correções necessárias ao seu aprimoramento;

II - formular e encaminhar as demandas recebidas aos órgãos competentes, em especial, às Diretorias da ANS;

III - dar ciência ao Diretor-Presidente e aos demais Diretores da ANS, de infringências de normas de assistência suplementar à saúde, às quais a OUVID tiver acesso, no cumprimento de sua missão;

IV - produzir, semestralmente, ou quando oportuno, relatórios com apreciações críticas sobre a atuação da ANS, encaminhando-os, em especial, à DICOL, ao Ministério da Saúde e a outros órgãos do Poder Executivo e Legislativo, disponibilizando estes relatórios para conhecimento geral, inclusive na página da ANS na rede mundial de computadores;

V - ouvir as reclamações de qualquer cidadão, relativas a infrações às normas da assistência suplementar à saúde;

VI - receber denúncias de quaisquer violações de direitos individuais ou coletivos de atos legais relacionados à assistência suplementar à saúde, bem como qualquer ato de improbidade administrativa, praticados por agentes ou servidores públicos de qualquer natureza, vinculados direta ou indiretamente às atividades da ANS;

VII - receber demandas dos agentes sujeitos ou não à regulação da ANS;

VIII - promover as ações necessárias à apuração das demandas recebidas e recomendar a adoção das providências necessárias ao atendimento das mesmas;

IX - manter e garantir o sigilo da fonte e a proteção do denunciante, quando for o caso;

X - encaminhar o fato denunciado para a Diretoria de Fiscalização quando se tratar de denúncia acerca de infração à legislação relativa à saúde suplementar;

XI - dar conhecimento imediato à PPCOR nos casos em que houver denúncia referente a atitudes inadequadas, ou a atos ilegais, ilícitos e de improbidade administrativos, praticados por agentes ou servidores públicos de qualquer natureza, vinculados direta ou indiretamente às atividades da ANS;

XII - exercer as atividades de ouvidoria interna, recebendo elogios, reclamações, sugestões e consultas do corpo funcional, e recomendar a adoção das providências necessárias para resolução de problemas que repercutam no desempenho institucional da ANS, nos termos de suas competências regimentais;

XIII - manter registro cadastral atualizado das ouvidorias privadas;

XIV - receber, analisar e avaliar as informações com base nos relatórios das ouvidorias privada;

XV - acompanhar a atuação das ouvidorias privadas, no âmbito do mercado de saúde suplementar;

XVI - instaurar e instruir o processo administrativo de apuração de infrações e aplicação de sanções por descumprimento da legislação de saúde suplementar, relativo ao não envio de informações periódicas de sua competência. (Brasil, 2017)

- **Corregedoria**

A Corregedoria é competente para fazer a fiscalização da legalidade das atividades e de apurar as irregularidades administrativas dos agentes públicos. Devendo prestar informações e opinar fundamentalmente, quando solicitado, sobre a permanência ou exoneração do agente no cargo. Compete também a PPCOR, investigar e instaurar processos disciplinares, e promover o desenvolvimento das ações para esclarecer, treinar e assim capacitar os agentes públicos sobre as normas de caráter disciplinar.

- **Auditoria Interna**

Em síntese, são competências da Auditoria Interna, fazer avaliação e acompanhamento dos desempenhos dos processos organizacionais, devendo fazer a elaboração e executar o Plano Anual de Auditoria Interna. Também é de sua competência examinar a elaboração do Contrato de Gestão, analisar e avaliar a execução orçamentária no que diz respeito a sua conformidade, os seus limites e sua destinação. Deve auditar os resultados do Programa de Qualificação Institucional, sendo todas as suas competências elencadas no art. 17 da Resolução.

- **Câmara de Saúde Suplementar**

Para auxiliar a Diretoria Colegiada foi criada pela Lei nº 9961/2000 a Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), que possui um caráter permanente e consultivo. O art. 13 da lei 9961/2000 dispõe sobre os integrantes da CAMSS, sendo ela integrada:

- pelo Diretor-Presidente da ANS ou seu substituto
- por um secretário que será um dos quatro diretores da ANS

- por um representante do Ministério da Fazenda
- por um representante do Ministério do Trabalho e Emprego
- por um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social
- por um representante do Ministério da Justiça
- por um representante do Ministério da Saúde
- por um representante dos seguintes órgãos:
  - Conselho Nacional de Saúde
  - Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde
  - Conselho Municipais dos Secretários Estaduais de Saúde
  - Conselho Federal de Medicina
  - Conselho Federal de Odontologia
  - Conselho Federal de Enfermagem
  - Federação Brasileira de Hospitais
  - Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços
  - Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas
  - Confederação Nacional da Indústria
  - Confederação Nacional do Comércio
  - Central Única dos Trabalhadores
  - Força Sindical
  - Social Democracia Sindical
  - Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
  - Associação Médica Brasileira
- por um representante das seguintes entidades:
  - segmento de autogestão de assistência à saúde
  - empresas de medicina de grupo
  - cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde suplementar

- empresas de odontologia de grupo
- cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar
- por dois representantes das seguintes entidades:
  - defesa do consumidor
  - associações de consumidores de planos privados de assistência à saúde
  - entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais.

Quem designará os membros da Câmara é o Diretor-Presidente da ANS, salvo as entidades, que elas próprias escolheram entre seus membros de cada categoria os seus representantes e suplentes.

É de competência da Câmara de Saúde Suplementar: observar e ajudar a criação de políticas no campo da saúde suplementar; para que possa melhorar as relações dos setores que compõe a ANS, a CAMSS discute, analisa e sugere medidas de melhoria para um bom relacionamento; ajuda na colaboração das discursões e dos resultados das câmaras técnicas; deve prestar auxílio a Diretoria Colegiada para aperfeiçoar o mercado da saúde suplementar, para que possa proporcionar a ANS condições de exercer de forma mais eficiente a sua função; deve indicar representantes sugeridos pela Diretoria para formar grupos técnicos temáticos.

Além da Câmara de Saúde Suplementar, faz parte da ANS as Câmaras e Grupos Técnicos. As Câmaras Técnicas vêm a ser o local para aprofundar as discussões dos assuntos que dizem respeito a saúde suplementar. Essas Câmaras são formadas temporariamente por especialistas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou por algum dos representantes do setor, podendo também atuarem em conjunto, através de convite da própria ANS que convida de acordo com a complexidade e a importância do assunto.

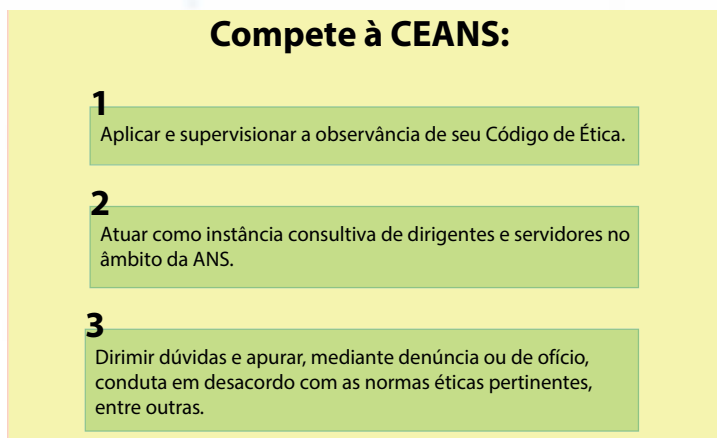
As Câmaras Técnicas devem obedecer a um regimento interno que foi anteriormente aprovado pela Diretoria Colegiada, possuindo assim, um caráter formal.

Com mesma estrutura e objetivos, mas para obter um estudo mais profundo e mais específico, são criados os Grupos Técnicos, porém esses não possuem o mesmo caráter formal das Câmaras Técnicas.

- **Comissão de Ética**

A Comissão de Ética da ANS, surgiu com o objetivo de zelar pelo cumprimento do Código de Ética da ANS, orientando todos os seus servidores e seus colaboradores para que sigam suas normas. O art. 19 da Resolução Regimental nº1 de 17 de março de 2017 da ANS traz todas as competências dessa comissão. Vejamos na figura 6:

Figura 6 – Competência da Comissão de Ética



Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar

A Comissão de Ética é formada por três membros titulares, sendo eles escolhidos pela Diretoria Colegiada e designados pelo Diretor Presidente, haverá o mesmo número de suplentes, e os mandatos serão de 3 anos podendo haver uma reeleição.

# Gestão Financeira e Orçamentária da Saúde Suplementar

## OBJETIVO



O aluno ao final desse capítulo poderá compreender melhor sobre o que vem a ser gestão financeira e orçamentária como um todo, obtendo conhecimento sobre receita e despesa, e no fim, ter conhecimento de como isso alcança a saúde suplementar.

## Conceito de Gestão Financeira e Orçamentária

Ao se falar em gestão financeira e orçamentaria, devemos voltar ao passado e perceber que esse assunto começou a ser tratado de fato, após a criação do Erário Régio e do Conselho da Fazenda. O Erário Régio, nasceu junto com o Conselho da Fazenda a partir de um decreto de 1908 e servia para que juntos expedissem todas transações referentes a arrecadação, distribuição e administração da Fazenda Real.

A criação do Erário Régio e do Conselho da Fazenda foi o ponto de partida para a elaboração de diversas leis que tratavam de assuntos públicos, a mais importante entre elas foi a Lei nº4320/64, que traz normas gerais de Direito Financeiro que serve para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, esta lei encontra-se em vigor até os dias de hoje.

Após a Lei nº4320/64 veio a Constituição Federal de 1988, trazendo mais exigências para a destinação dos recursos públicos, determinando e controlando os gastos públicos e exigindo para onde devem ser destinados os recursos públicos.

Entende-se por gestão financeira os métodos e as condutas administrativas que estão ligadas à análise, controle e planejamento das atividades financeiras. Uma boa gestão financeira, garante que se tenha mais dinheiro, servindo para manutenção, investimento e crescimento, além disso, proporciona uma redução de gastos retirando os desnecessários e destinando os recursos para os lugares certos. Uma boa gestão financeira garante uma correta administração dos recursos financeiros.

Em conjunto com a gestão financeira, vem o orçamento, que corresponde as ações e as estratégias empregadas em um negócio, que visa a utilização correta dos recursos financeiros.

Ao analisarmos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nota-se que seu desenvolvimento requer investimentos elevados, pois além das suas funções estabelecidas, a agência deve cumprir o que foi estabelecido no contrato de gestão, devendo, junto com o Ministério da Saúde participar do processo de construção da proposta orçamentária da União, da mesma forma dos demais órgãos que integra a administração pública federal. As instruções para realização do processo orçamentário estão contidas no Manual Técnico de Orçamento – MTO.

Na proposta orçamentaria irá conter os orçamentos fiscais, os referentes a seguridade social e os de investimentos, que seguem para ser aprovada pelo Congresso Nacional e posteriormente sancionada pelo Presidente da República, se tornando a Lei Orçamentária Anual. Essa Lei é direcionada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo Plano Plurianual que é um dispositivo de planejamento de médio prazo do governo federal, que tem como base estabelecer por região as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal.

Toda e qualquer despesa pública só é considerada efetiva quando estiver em conformidade com a lei, assim, as receitas e as despesas públicas são autorizadas pela Lei Orçamentária. Desta forma, o poder público arrecada todos os recursos que necessita para que possa efetuar os gastos visando o bem comum.



## EXPLICANDO MELHOR

Assim, o orçamento é que torna possível a realização dos programas anuais de acordo com a quantidade de metas e a destinação dos recursos necessários para as ações programadas.

Para que as propostas previstas no orçamento sejam alcançadas, as receitas que foram previstas devem ter sido arrecadadas e disponibilizadas no tempo certo e, as despesas, devem ser gastas de acordo com as instruções. Também, as ações devem produzir os efeitos esperados que, assim, consequentemente os propósitos firmados serão alcançados.

O objetivo da Lei da Responsabilidade Fiscal é de controlar os gastos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, garantindo que as arrecadações sejam precisas, exigindo dos entes a explicação de como foram efetuados os cálculos e garantindo que a anistia, subsídio, renúncia, remissão, isenções, etc, seja de acordo com o estabelecido na Lei das Diretrizes Orçamentárias e suas metas de acordo com a Lei Orçamentária Anual.

Receitas públicas são as entradas de dinheiro nos cofres públicos, por meio de taxas, contribuições, impostos, entre outros. Esse dinheiro se integra ao patrimônio do Estado, e a partir daí ele distribui para que sejam custeadas as despesas públicas e para que comecem a fazer os investimentos públicos.

Quando se fala em despesa pública, refere-se aos gastos realizados pelos entes públicos com o intuito de pagar todas as contas fixadas em lei, objetivando o funcionamento dos serviços públicos. Assim, as despesas fazem parte do orçamento público.

Conforme o art. 12 da Lei nº4320/64 as despesas são divididas em despesas correntes que compreendem as despesas de custeio e as transferências correntes, e as despesas de capital que correspondem aos investimentos, as inversões financeiras e as transferências de capital.

- Despesas de custeio – quantias destinadas para manutenção de serviços já criados.

- Transferências correntes – quantias destinadas para as despesas que não dizem respeito a contraprestações direta de bens e serviços.
- Investimentos – quantias destinadas para planejamento e execução de obra, assim como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material que seja permanente.
- Inversões Financeiras – quantias destinadas a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, desde que, a operação não ocasione um aumento no capital, constituição ou aumento no capital das empresas ou entidades que tem objetivos comerciais ou financeiros.
- Transferência de Capital – quantias destinadas a investimentos ou aplicações financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar.

## Infraestrutura Básica da ANS



### OBJETIVO

É considerado patrimônio da Agência Nacional de Saúde Suplementar os bens e direitos da sua propriedade, também aqueles que lhe forem conferidos e os que ocasionalmente venham a adquirir.

O Capítulo IV da Lei nº9961/2000 estabelece sobre o patrimônio, as receitas e a gestão financeira da ANS, o art. 17 desta lei, traz o rol das receitas dessa agência, sendo:

Art. 17. Constituem receitas da ANS:

I - o produto resultante da arrecadação da Taxa de Saúde Suplementar de que trata o art. 18;

II - a retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;

III - o produto da arrecadação das multas resultantes das suas ações fiscalizadoras;

IV - o produto da execução da sua dívida ativa;

V - as dotações consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;

VI - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades ou organismos nacionais e internacionais;

VII - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

VIII - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;

IX - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações;

X - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo, na forma definida pelo Poder Executivo;

XI - quaisquer outras receitas não especificadas nos incisos I a X deste artigo.

Parágrafo único. Os recursos previstos nos incisos I a IV e VI a XI deste artigo serão creditados diretamente à ANS, na forma definida pelo Poder Executivo. (Brasil, 2000)



Fonte: @freepik

De acordo com o que foi estudado sobre receita, o art.17 acima mencionado traz a forma que a ANS arrecada dinheiro, tendo sua arrecadação própria firmada a partir do ano 2000. Importante salientar que com o enorme crescimento dos adeptos a saúde suplementar, a ANS tem se estabilizado com seu próprio orçamento, necessitando cada vez menos da ajuda do governo, isso graças a Taxa de Saúde Suplementar.

A Taxa de Saúde Suplementar acima mencionada, nasceu com a Lei nº9961/2000, essa taxa é dividida entre todas as pessoas jurídicas de saúde suplementar. Ela é vinculada ao registro das operadoras e dos produtos e as prestadoras de serviço de plano de saúde, que é cobrada de acordo com o número de usuários.

Conforme o art. 20 dessa mesma lei, deverá pagar a Taxa de Saúde Suplementar:

Art. 20. A Taxa de Saúde Suplementar será devida:

I - por plano de assistência à saúde, e seu valor será o produto da multiplicação de R\$ 2,00 (dois reais) pelo número médio de usuários de cada plano privado de assistência à saúde, deduzido o percentual total de descontos apurado em cada plano, de acordo com as Tabelas I e II do Anexo II desta Lei;

II - por registro de produto, registro de operadora, alteração de dados referente ao produto, alteração de dados referente à operadora, pedido de reajuste de contraprestação pecuniária, conforme os valores constantes da Tabela que constitui o Anexo III desta Lei.

§ 1º Para fins do cálculo do número médio de usuários de cada plano privado de assistência à saúde, previsto no inciso I deste artigo, não serão incluídos os maiores de sessenta anos.

§ 2º Para fins do inciso I deste artigo, a Taxa de Saúde Suplementar será devida anualmente e recolhida até o último dia útil do primeiro decêndio dos meses de março, junho, setembro e dezembro e de acordo com o disposto no regulamento da ANS.

§ 3º Para fins do inciso II deste artigo, a Taxa de Saúde Suplementar será devida quando da protocolização do requerimento e de acordo com o regulamento da ANS.

§ 4º Para fins do inciso II deste artigo, os casos de alteração de dados referentes ao produto ou à operadora que não produzam consequências para o consumidor ou o mercado de saúde suplementar, conforme disposto em resolução da Diretoria Colegiada da ANS, poderão fazer jus a isenção ou redução da respectiva Taxa de Saúde Suplementar.

§ 5º Até 31 de dezembro de 2000, os valores estabelecidos no Anexo III desta Lei sofrerão um desconto de 50% (cinquenta por cento).

§ 6º As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de recursos humanos, ou de filantropia, ou que tenham número de usuários inferior a vinte mil, ou que despendem, em sua rede própria, mais de sessenta por cento do custo assistencial relativo aos gastos em serviços hospitalares referentes a seus Planos Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao menos trinta por cento de sua atividade ao Sistema Único de Saúde - SUS, farão jus a um desconto de trinta por cento sobre o montante calculado na forma do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.097-36, de 2001) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 7º As operadoras de planos privados de assistência à saúde que comercializam exclusivamente planos odontológicos farão jus a um desconto de cinquenta por cento sobre o montante calculado na forma do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.097-36, de 2001) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 8º As operadoras com número de usuários inferior a vinte mil poderão optar pelo recolhimento em parcela única no mês de março, fazendo jus a um desconto de cinco por cento sobre o montante calculado na forma do inciso I deste artigo, além dos descontos previstos nos §§ 6º e 7º, conforme dispuser a ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.097-36, de 2001) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 9º Os valores constantes do Anexo III desta Lei ficam reduzidos em cinquenta por cento, no caso das empresas com número de usuários inferior a vinte mil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.097-40, de 2001) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 10. Para fins do disposto no inciso II deste artigo, os casos de alteração de dados referentes a produtos ou a operadoras,

até edição da norma correspondente aos seus registros definitivos, conforme o disposto na Lei nº 9.656, de 1998, ficam isentos da respectiva Taxa de Saúde Suplementar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-43, de 2001) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 11. Para fins do disposto no inciso I deste artigo, nos casos de alienação compulsória de carteira, as operadoras de planos privados de assistência à saúde adquirentes ficam isentas de pagamento da respectiva Taxa de Saúde Suplementar, relativa aos beneficiários integrantes daquela carteira, pelo prazo de cinco anos. (Brasil, 2000)

A tabela a seguir demonstrada na figura 9 mostra o avanço da receita da ANS dos anos 2010 a 2019.

Figura 9 - Receita de contraprestações das operadoras (em Reais) (Brasil - 2010-2019)

| Ano  | Receita de contraprestações | Outras receitas operacionais | Despesa assistencial | Despesa administrativa | Despesa de comercialização | Outras despesas operacionais |
|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2010 | 74.539.331.508              | 18.145.790.904               | 59.711.429.527       | 12.338.786.866         | 2.322.414.750              | 12.494.352.603               |
| 2011 | 84.821.575.963              | 19.750.658.043               | 68.864.809.673       | 13.204.508.561         | 2.745.924.331              | 14.154.092.321               |
| 2012 | 95.853.680.339              | 20.360.813.441               | 80.112.826.811       | 14.261.625.566         | 3.152.901.509              | 13.682.829.619               |
| 2013 | 109.927.620.595             | 14.910.319.352               | 90.925.302.328       | 15.017.643.463         | 3.501.861.811              | 14.132.771.296               |
| 2014 | 127.777.444.503             | 14.910.944.501               | 106.496.081.722      | 16.816.617.032         | 4.172.816.917              | 15.048.990.235               |
| 2015 | 144.701.906.083             | 15.333.832.284               | 120.119.877.388      | 17.830.659.710         | 4.839.088.798              | 16.111.089.254               |
| 2016 | 163.246.294.916             | 17.240.240.037               | 137.123.914.097      | 19.372.921.338         | 5.384.362.883              | 17.946.513.808               |
| 2017 | 180.893.859.503             | 17.028.477.006               | 150.583.574.465      | 20.176.363.171         | 5.455.991.738              | 18.025.945.719               |
| 2018 | 197.438.238.418             | 13.268.654.502               | 161.469.397.459      | 20.578.358.346         | 5.924.588.751              | 16.236.544.754               |
| 2019 | 158.774.032.894             | 9.752.599.709                | 130.776.315.585      | 15.908.779.726         | 4.813.022.814              | 11.874.727.011               |

Fontes: DIOPS/ANS/MS - 29/11/2019

Notas: 1. Dados de 2019 referentes ao acumulado do 3º trimestre.

Como visto na tabela acima, a receita da ANS vem crescendo cada ano mais, aumentando assim sua autonomia graças a Taxa de Saúde Suplementar.

Quanto a sua gestão, a ANS é obrigada a fazer anualmente um relatório de gestão, devendo apresentar aos órgãos de controle interno e externo de acordo com o que determina o art. 70 da Constituição Federal. Esse documento deve conter as realizações administrativas, orçamentárias, financeiras e operacionais da ANS e, quem é responsável pela avaliação desse documento é a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União e quem elabora esse relatório como já estudado é a Diretoria de Gestão (DIGES).

A ANS possui despesas administrativas e despesas assistenciais.

As despesas administrativas dizem respeito à soma não relacionada as despesas de prestação direta que são informadas pelas operadoras dos serviços de assistência à saúde.

As despesas assistenciais ao contrário das administrativas, diz respeito à soma relacionada as despesas de prestação direta que são informadas pelas operadoras dos serviços de assistência à saúde.

---

### ACESSE



No site do portal da transparência é possível visualizar todos os valores pagos de despesa e o orçamento realizado da ANS, confira acessando o link <https://bit.ly/393vUot> (Acesso em 20 de janeiro de 2020)

---

### RESUMINDO



Por fim, no portal da transparência existem todas as despesas realizadas pela ANS, onde também é possível visualizar quanto é gasto e quanto é recebido e como se é trabalhado, tendo em vista que estudamos sobre suas diretorias e vimos a função de cada uma, fica claro a transparência de como esse dinheiro é utilizado.

---

# BIBLIOGRAFIA

BRASIL. A Constituição e o Supremo. Documento elaborado pelo site do Supremo Tribunal Federal. <<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=1831>> Acesso em 17 de janeiro de 2020

----- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre os dados gerais dos beneficiários dos planos de saúde. <<http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais>> Acesso em 17 de janeiro de 2020

----- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre a Câmara de Saúde Suplementar <<http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camss-camara-de-saude-suplementar>> Acesso em 17 de janeiro de 2020

----- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre as prestações de contas <<http://www.ans.gov.br/index.php/aans/transparencia-institucional/prestacao-de-contas/155-contratos-de-gestao>> Acesso em 17 de janeiro de 2020

----- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre a Diretoria Colegiada <<http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos/diretoria-colegiada>> Acesso em 17 de janeiro de 2020

----- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre a Secretária Geral <<http://ans.gov.br/aans/quem-somos/organograma/493-estrutura-e-atribuicoes-na-agencia-nacional-de-saude-suplementar-ans-seger-secretaria-geral>> Acesso em 18 de janeiro de 2020

----- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre a Comissão de Ética <<http://www.ans.gov.br/aans/comissao-de-etica>> Acesso em 18 de janeiro de 2020

# Livro Didático Digital

Milena Barbosa de Melo e  
Cristina Spengler Lambuja



TeleSapiens